

核心精讲·生殖系统疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图



一、宫颈疾病

(一) 慢性宫颈炎

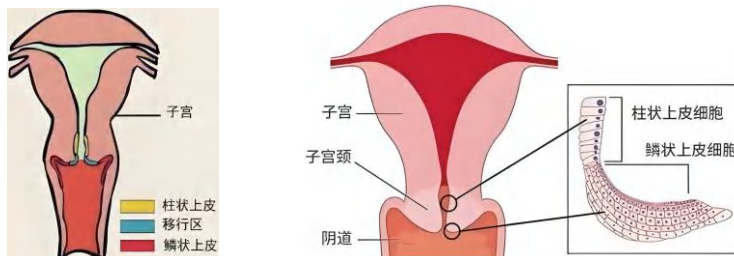
(1) 宫颈**息肉**(好慢呐米西)

(2) **假性宫颈糜烂**



①雌激素使宫颈管柱状上皮增生下移到达宫颈阴道部，即**宫颈柱状上皮异位**(不是柱状上皮化生)，由于柱状上皮较薄、上皮下血管较易显露而呈红色，加之柱状上皮呈乳头状突起、肉眼看起来好像发生了糜烂(不是真的糜烂-糜烂指上皮坏死脱落形成的浅表缺损)，此为正常的生理现象(不是病) ttsx

②异位的柱状上皮在阴道酸性环境刺激下发生**鳞状上皮化生**(鳞状上皮替代柱状上皮)，形成新的鳞-柱状上皮交界处

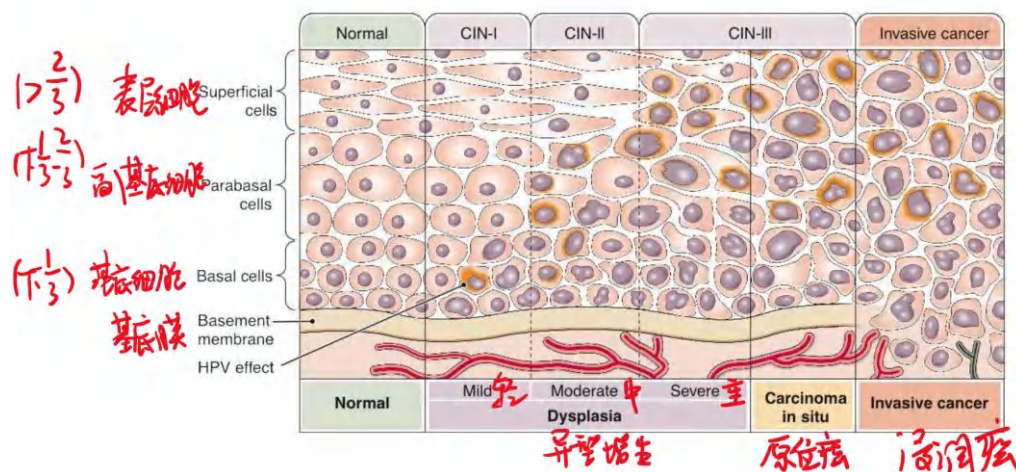
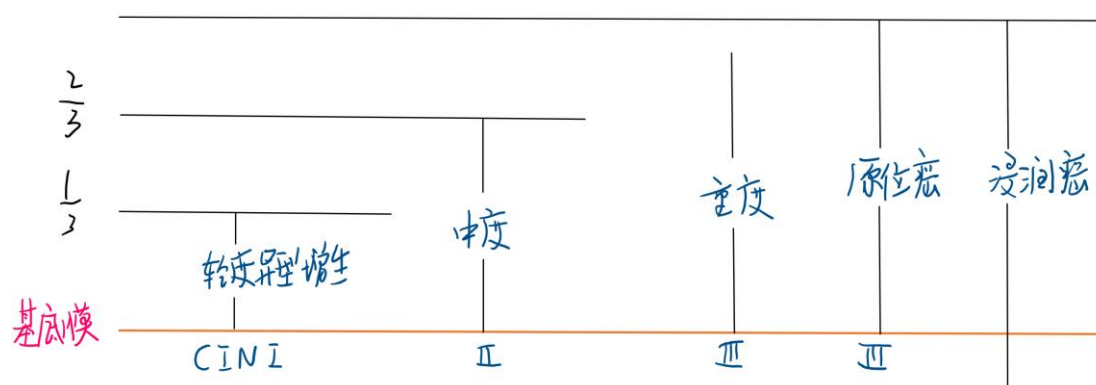


(3) **纳博特囊肿**: 新生的鳞状上皮覆盖阻塞子宫颈管腺体开口→粘液潴留在腺管内

(二) 宫颈癌

1. **癌前病变：宫颈鳞状上皮内病变**，即子宫颈上皮部分被不同程度异型性的细胞取代，出现**挖空细胞**或鳞状上皮细胞**异型增生**。低级别鳞状上皮内病变 LSIL 常可消退

鳞状上皮内病变 SIL	上皮内瘤变 CIN	鳞状上皮范围	细胞异型显著 可见核分裂象
低级别 LSIL	I级	下 1/3	轻度异型增生
高级别 HSIL	II级	下 2/3	中度异型增生
	III级	下 2/3 以上或全层 (但未突破基底膜)	重度异型增生和原位癌 可见病理性核分裂象



注意：异型细胞可由表面沿基底膜通过子宫颈腺口蔓延至子宫颈腺体内、取代部分或全部腺上皮，但仍未突破腺体的基底膜，称为 CIN III累及腺体

2. 病因：人乳头瘤病毒 HPV 尤其 16、18 型

① HPV 编码的 E₆ 蛋白使 p53 失活、E₇ 蛋白使 RB 失活 (5678)

② 免疫组化 p16 弥漫强阳性可辅助诊断 HSIL (p16 蛋白是高危型 HPV 基因表达的指标)

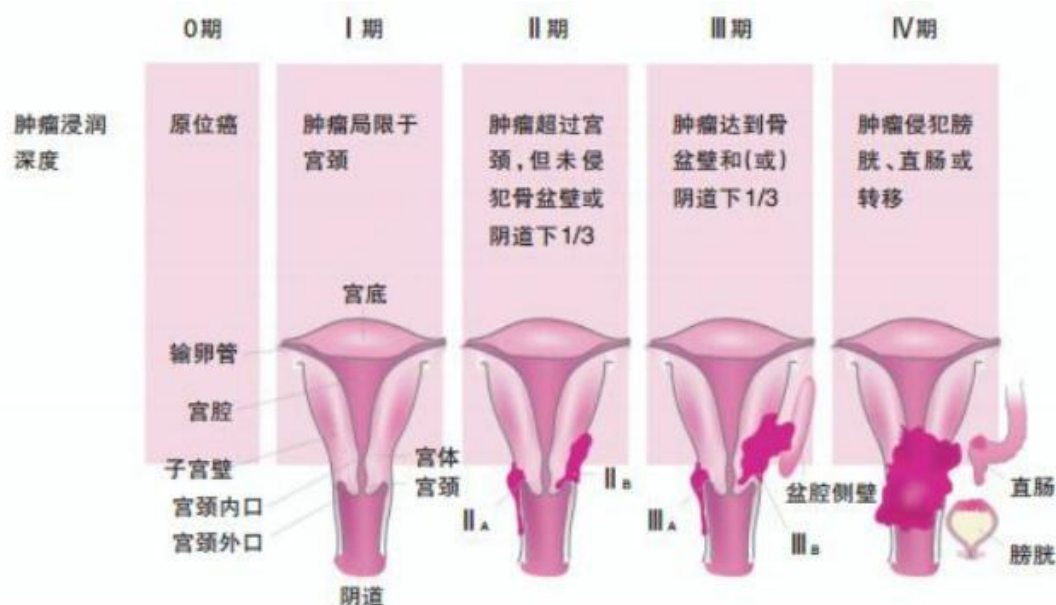
3. 鳞癌最常见

4. 好发于鳞-柱状上皮交界处 (移行带)。若 HPV 感染原始的鳞-柱状上皮交界处则与化生无关；若 HPV 感染新的鳞-柱状上皮交界处则与化生有关

5. 最早和最常见扩散：淋巴转移 (最早转移至子宫旁淋巴结) 和直接蔓延

6. 临床分期 (0 期-原位癌)

I	癌局限于子宫颈内 ① 早期/微小浸润癌：浸润深度 ≤ 基底膜下 5mm ② 浸润癌：浸润深度 > 基底膜下 5mm
II	癌进入盆腔、但未累及盆腔壁；癌侵及阴道、但未累及阴道下 1/3
III	癌侵及盆腔壁、阴道下 1/3 (阴字偏旁像 3；删我)
IV	癌已超越骨盆、或累及膀胱或直肠



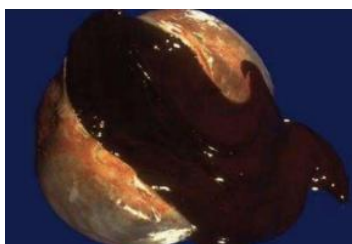
二、宫体疾病

（一）子宫内膜异位症

①子宫内膜腺体和间质出现在子宫内膜以外的部位。若异位于子宫肌层（且距离子宫内膜基底层 2mm 以上）称为**子宫腺肌病/瘤**

②**卵巢（最常见）、**子宫阔韧带等

③受 ttsx 卵巢分泌激素的影响，异位的子宫内膜产生周期性反复出血，导致卵巢体积增大、形成囊肿，囊内含粘稠的咖啡色样液体（**陈旧血液**），称为**巧克力囊肿**



（二）子宫内膜增生症

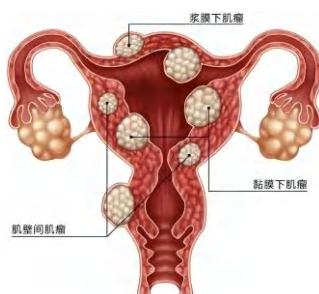
①**雌激素**↑致子宫内膜腺体或间质增生（增生期与雌激素有关）

②病理变化

	增生不伴不典型性 (包括以前的单纯性增生、复杂性增生)	异型增生 (不典型增生)
发展为 子宫内膜腺癌 几率	1-3%	1/3
腺体增多	可背靠背 (腺体排列拥挤致腺体与腺体相邻)	明显背靠背 无子宫内膜间质浸润 (区别于癌)

（三）子宫平滑肌瘤

（1）肿瘤可位于黏膜下、肌层、浆膜下、子宫腔、宫颈口外，以**肌层**最常见



(2) 子宫平滑肌瘤虽为良性肿瘤、但无包膜，瘤细胞与正常子宫平滑肌细胞相似、但呈漩涡/编织/束状排列

(3) 子宫平滑肌瘤的肌瘤变性

①玻璃样变/透明变性（最常见）：漩涡状结构由透明样物质取代

②红色变性（妊娠期多见）：肌瘤间质血管血栓形成致局部坏死、出血

注意：子宫平滑肌肉瘤——肿瘤边界不清、细胞异型显著、**核分裂象增多（主要）**

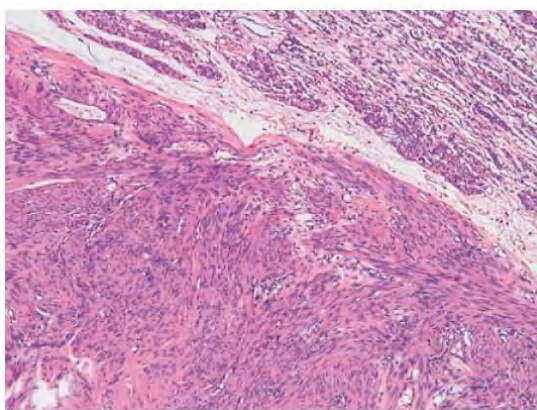


图 14-8 子宫平滑肌瘤

瘤细胞束状或漩涡状排列，瘤细胞呈长梭形，肿瘤组织与周围正常组织境界清楚（100 倍）。

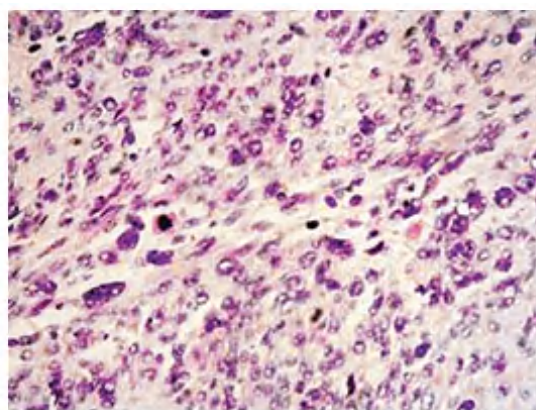


图 14-9 子宫平滑肌肉瘤

瘤细胞密集呈梭形或椭圆形，大小不等、形状不一，可见核分裂象。

三、滋养细胞疾病

滋养细胞疾病的**共同特征**是**滋养层细胞异常增生**，人绒毛膜促性腺激素 **hCG** 含量高于正常妊娠

滋养细胞疾病包括：

葡萄胎	完全性、部分性、侵袭性
肿瘤	绒毛膜癌、胎盘部位滋养细胞肿瘤、上皮样滋养细胞肿瘤
非肿瘤性病变	
异常绒毛病变	

(一) 葡萄胎 VS 绒癌

	良性葡萄胎（完全性、部分性）	恶性葡萄胎（侵袭性葡萄胎）	绒毛膜癌/绒癌（多继发于完全性葡萄胎）
合体滋养层细胞增生 细胞滋养层细胞增生	√	比 良性葡萄胎 显著	比 侵袭性葡萄胎 显著
滋养层细胞 异型增生、坏死出血	轻度		
间质	间质水肿 血管消失		无间质和血管 绒癌无血管、那怎么获取营养啊？不用你操心，绒癌侵袭宿主血管、直接泡在母体血管，是最易血道转移的癌
绒毛 	√	√	× (异型性大-分化低) 三无产品：鱼香肉丝没有鱼、老婆饼没有老婆 ttsx
侵犯子宫 肌层 和或血管	×	√（水泡状绒毛侵入子宫肌层）	√ (但 无水泡状绒毛)
阴道蓝紫色结节	×	√	√
转移	×	几乎×	√ 血道转移：肺 最常见→ 咯血 原发灶切除后转移灶可自行消退
主要治疗	彻底清宫	化疗	化疗

注意：阴道蓝紫色结节

①绒癌：经血管转移至阴道致阴道出血坏死

②侵袭性葡萄胎：绒毛入血作为栓子、经血管至阴道造成栓塞致阴道出血坏死（绒毛无法继续生长）



图 14-12 子宫绒毛膜癌
癌组织位于子宫底部，呈暗紫红色，结节状，可见出血坏死。

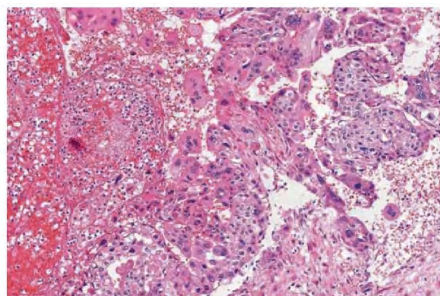


图 14-13 绒毛膜癌
由细胞滋养层和合体滋养层两种瘤细胞组成，细胞异型性明显，肿瘤内无间质和血管。

(二) 葡萄胎

1. 胎盘绒毛因间质高度**水肿**、**黏液样变性**而增大，呈葡萄状，称为水泡状胎块（无血管-透明），绒毛**间质内血管消失**、或有少量无功能毛细血管（内无红细胞），**滋养层细胞异型增生**（风到这里就是粘、粘住过客的葡萄。这节课后你将失去对巧克力/葡萄/橘子的兴趣）



图 14-10 葡萄胎
子宫体积增大，子宫腔内充满大小不等的透明水泡。

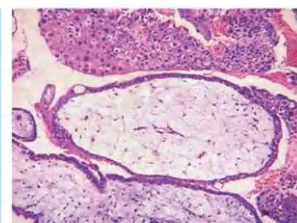
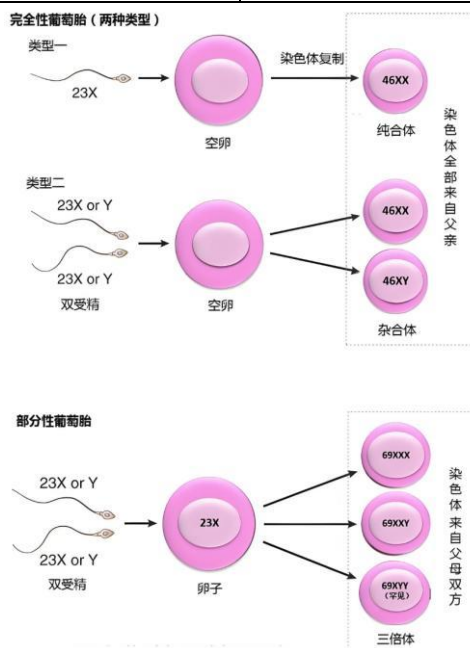


图 14-11 完全性葡萄胎
胎盘绒毛显著肿大，间质水肿，血管消失，滋养层细胞明显增生。

2. 完全性 VS 部分性葡萄胎

完全性葡萄胎完全 2 个字	部分性葡萄胎不完全 3 个字
所有绒毛呈葡萄状	部分绒毛呈葡萄状
①主要：一个精子 23X 结合缺乏染色体的空卵 精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合缺乏染色体的空卵	①一个双倍体精子 46XY 结合染色体数量正常的卵细胞 23X 精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合染色体数量正常的卵细胞 23X
双倍体核型：46XX（主要）、46XY	三倍体核型：69XXX、69XXY、69XYY
染色体全部来自父亲	染色体来自父母双方
无胎儿组织	可有胎儿组织
无 p57 核染色	有 p57 核染色

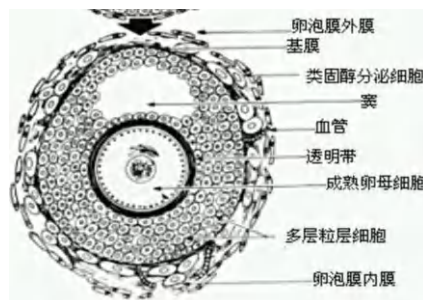
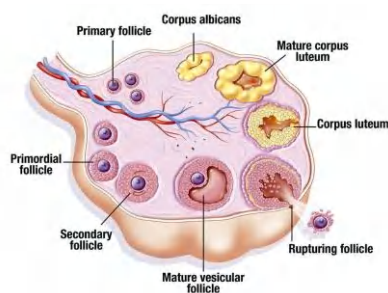


（三）胎盘部位滋养细胞肿瘤（恶性）

- ①多数人胎盘催乳素 hPL+、少数 hCG+
- ②**单一**的中间型滋养细胞（VS 绒癌为两种细胞）
- ③无绒毛，可侵犯肌层、可转移

四、卵巢肿瘤

卵泡包括中央的卵母细胞和周围的卵泡细胞（性索间质）



上皮性肿瘤（最常见）	浆液性/黏液性囊腺瘤/囊腺癌等
由卵母细胞发生的为 生殖细胞肿瘤 膜内无鸡胚	畸胎瘤、无性细胞瘤（恶性）、内胚窦瘤/卵黄囊瘤、胚胎性癌、绒毛膜癌
由卵泡细胞发生的为 性索间质肿瘤 支持一粒卵泡	粒层细胞瘤/颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤、支持-间质细胞瘤（主要发生在睾丸、肿瘤分泌雄激素）

1. 上皮性肿瘤举例

浆液性肿瘤（发病率高）	黏液性肿瘤
囊腔内含清亮囊液和实性结节	多个囊腔、内含黏稠囊液和实性结节
乳头多见（恶性者更多） 双儒将	乳头少见
累及双侧卵巢多见	累及单侧卵巢多见
恶性即 浆液性囊腺癌 ：癌细胞浸润间质、 砂粒体/钙化小体 又是乳头又是癌（甲状腺乳头状癌） 脑膜瘤也可有砂粒体	恶性即黏液性囊腺癌：癌细胞浸润间质

注意：卵巢黏液性癌可为原发（本节所学，累及单侧卵巢多见）
可为继发（胃肠黏液癌尤其胃印戒细胞癌种植性转移至卵巢，累及双侧卵巢多见）

双侧卵巢的恶性肿瘤首先考虑 **Krukenberg 瘤**

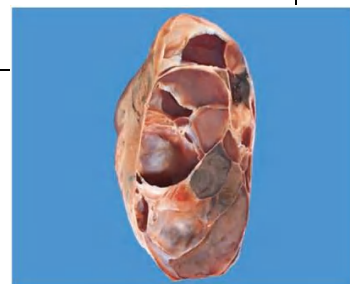


图 14-17 卵巢黏液性囊腺癌
肿瘤表面光滑，包膜完整，由多个大小不一的囊腔组成，其中某些腔内充满富于糖蛋白的黏稠液体。

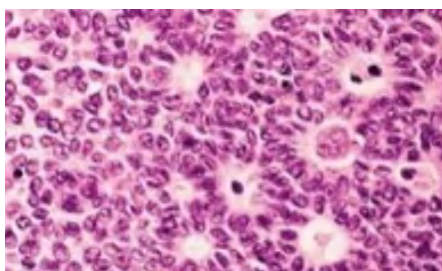
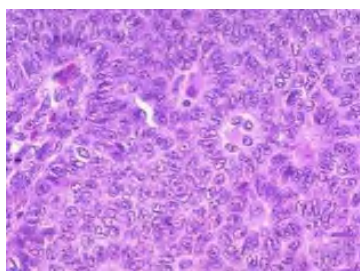
2.生殖细胞肿瘤举例

畸胎瘤	内胚窦瘤/卵黄囊瘤
良性 （成熟 懂事 ） 恶性 （未成熟）	高度 恶性
多含 ≥ 2 个胚层成分（ 各种组织均有 如皮肤、毛囊、脂肪） 良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿 恶性：未成熟 原始神经管和菊形团、骨和软骨等 （复习：小细胞肺癌可围绕小血管形成假菊形团结构）	AFP 升高 疏网状结构 S-D 小体 嗜酸性小体 ASSS



3.性索间质肿瘤举例

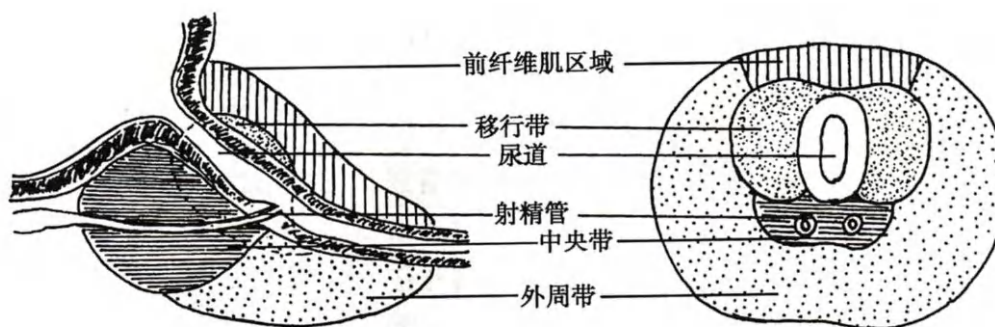
粒层细胞瘤/颗粒细胞瘤	卵泡膜细胞瘤
低度 恶性	良性 卵泡膜细胞离卵母细胞远
肿瘤分泌 雌 激素	肿瘤分泌 雌 激素
核沟、咖啡豆样，Call-Exner 小体 粒粒咖啡豆 coffee （复习：甲状腺乳头状癌也有核沟）	细胞质富含脂肪（空泡状） 卵脂



五、前列腺增生 VS 前列腺癌

(与雄激素有关)

前列腺增生/肥大	前列腺癌
好发于 移行带	好发于 外周带 曾毅爱粥
淀粉小体 qian-dian	① 缺失基底细胞 ②可经椎旁静脉转移至脊椎 骨 等 ③ PSA、酸性磷酸酶 摸前列腺好酸爽



真题解析·生殖系统疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2014N164 X 良性畸胎瘤内可出现的组织有

- A.脑组织
- B.软骨组织
- C.甲状腺组织
- D.皮肤及其附属器

2015N54 A 与子宫内膜癌关系不密切的子宫内膜变化是

- A.单纯性增生
- B.复杂性增生
- C.非典型增生
- D.增殖期子宫内膜

2016N54 A 以下选项中，不属于绒毛膜上皮癌的病理特征是

- A.高度水肿的绒毛
- B.出血坏死明显
- C.没有肿瘤间质成分
- D.肿瘤细胞高度异型

2017N39 A 在子宫肌层内发现水肿的绒毛，诊断为

- A.葡萄胎
- B.绒毛状腺瘤
- C.绒毛膜上皮癌
- D.侵袭性葡萄胎

2017N151 X 以下病变中，属于子宫颈 CIN III的有

- A.轻度异型增生
- B.中度异型增生
- C.重度异型增生
- D.原位癌

2019N39 A 在下列描述中，子宫颈癌I期的是

- A.癌细胞尚未突破基底膜
- B.癌细胞浸润并局限于子宫颈内
- C.癌细胞分化较成熟
- D.癌细胞浸润范围超过子宫颈

2019N149 X 绒毛膜癌区别于恶性葡萄胎的病理特点有

- A.呈浸润性生长
- B.出血、坏死更明显
- C.滋养细胞增生
- D.无绒毛和水泡形成

2020N38 A 在子宫颈活检组织中，见异型上皮细胞累及全层并突破基底膜向下生长 3mm，应诊断为

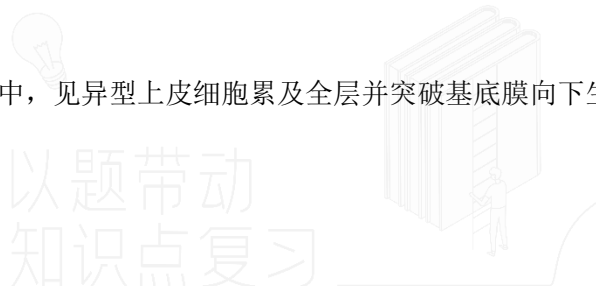
- A.子宫颈原位癌
- B.子宫颈原位癌累及腺体
- C.子宫颈早期浸润癌
- D.子宫颈浸润癌

2021N39 A 绒毛膜癌的组织学特点是

- A.肿瘤本身无间质血管
- B.癌细胞形成绒毛结构
- C.癌组织出血坏死不明显
- D.由分化不良的细胞滋养层细胞构成

2022N32 A 前列腺癌血道转移最常见的部位是

- A.肝
- B.肾
- C.骨
- D.肺



2022N37 A 高危型 HPV 感染可引起宫颈癌的重要机制是

- A.病毒能编码 E₂ 和 E₃ 蛋白
- B.病毒能编码 E₄ 和 E₅ 蛋白
- C.病毒能编码 E₆ 和 E₇ 蛋白
- D.病毒能编码 E₈ 和 E₉ 蛋白

2024N151 X 关于完全性葡萄胎的叙述，正确的有

- A.均为男性遗传起源
- B.核型为二倍体
- C.可以有胎儿存在
- D.水肿的绒毛间质内血管增生

2025N40 A 关于绒毛膜癌病理学特点的叙述，正确的是

- A.肉眼观，肿瘤呈灰白色、质硬
- B.由分化不良的两种滋养层细胞组成
- C.肿瘤血管丰富，出血、坏死明显
- D.部分癌细胞形成绒毛和水泡状结构

思维导图·生殖系统疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

